

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Για να συνταγογραφηθεί μια Κινολόνη ή μια Κεφαλοσπορίνη 3^{ης} ή 4^{ης} γενεάς, εκτός πλαισίου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, χρειάζεται το ειδικό έντυπο, καθώς και συνοδευτικό αντιβιόγραμμα (*test ευαισθησίας*) της καλλιέργειας του βιολογικού υγρού.

Στην ειδική συνταγή αναγράφονται και ενδεικτικά στοιχεία του αντιβιογράμματος, (π.χ. είδος υλικού, όνομα εργαστηρίου, ημερομηνία εξέτασης), με μονογραφή και σφραγίδα.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ,
ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ & ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΩΝ
Γ' ΓΕΝΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: / /

Ονοματεπώνυμο Ιατρού / Ειδικότητα:

Νοσηλευτικό Ίδρυμα:

Ιδιωτικό Ιατρείο / Διεύθυνση:

Ονοματεπώνυμο Ασθενούς:

Διεύθυνση κατοικίας:

Διάγνωση:

Rp.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Αντοχή σε άλλα παλαιότερα αντιμικροβιακά κ.λπ.
(Επισυνάπτεται το αποτέλεσμα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα).
2. Άλλη αιτία.
3. Συνέχιση συνταγής Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής.
(Αρ. μητρώου ασθενούς και ημερομηνία εισαγωγής).

Σημειώσεις:

Υπογραφή - Σφραγίδα Ιατρού

Ο φαρμακοποιός αφού εκτελέσει τη χειρόγραφη συνταγή, επισυνάπτει στο ειδικό αυτό έντυπο προχωρημένου αντιβιοτικού και το αντιβιόγραμμα, προς το ασφαλιστικό ταμείο.

Υπάρχουν όμως ορισμένες παθήσεις ή κλινικές καταστάσεις στις οποίες - και μόνον σε αυτές - είναι δυνατό να συνταγογραφηθούν Κινολόνες ή Κεφαλοσπορίνες 3^{ης} ή 4^{ης} γενεάς, χωρίς συνοδό αντιβιόγραμμα, παρά μόνο με την αναγραφή της ειδικής αυτής παθήσεως.

Αυτό αφορά στις παρακάτω εξής περιπτώσεις:

1. Αποδεδειγμένη οξεία (ΟΒΠ) ή χρόνια προστατίτιδα, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από την παρουσία πυσσφαιρίων στο δείγμα προστατικού υγρού ή ούρων που ελήφθη μετά από μάλαξη του προστάτη (*απαιτείται εξέταση Stamey - Meares*) ή στο σπερμοδιάγραμμα ή σε βιοψία προστάτη, εξετάσεις οι οποίες πρέπει να επισυνάπτονται στη συνταγή.
2. Οστεομυελίτιδα από Gram αρνητικά μικρόβια (*Brucella, Enterobacter, Pseudomonas*).
3. Ινοκυστική νόσος παιδιών ή ενηλίκων, με συνοδό λοίμωξη του αναπνευστικού.
4. Σύσταση για 3ήμερη αντιβιοτική αγωγή, σε διάρροια των ταξιδιωτών (*εντεροτοξινογόνο E. coli - ETEC*) ή σοβαρή εμπύρετη γαστρεντερίτιδα από *Salmonella spp.* ή *Shigella spp.*
5. Εμπύρετο σε ασθενείς με υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια (*λευχαιμία, λέμφωμα, μνέλωμα*), συμπαγείς όγκους, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και HIV λοίμωξη.
6. Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα (*όχι η ψευδομοναδική ωτίτιδα των κολυμβητών*).
7. Εκρίζωση χρόνιου αποικισμού Γονοκόκκου από τον φάρυγγα και τον πρωκτό.
8. Εναλλακτική χορήγηση - σε εφάπαξ δόση - προληπτικά, στο άμεσο περιβάλλον ασθενών με οξεία μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο (*Neisseria meningitidis*).
9. Βακτηριακή κερατίτιδα [για κολλύρια με νεότερες κινολόνες (*coll. Setraxal*)], όπως σε επιμολυνθέν τραύμα, κακή χρήση φακών επαφής, ξηροφθαλμία συνδρόμου Sjögren].

Οι από του στόματος Κεφαλοσπορίνες της 3^{ης} γενεάς (π.χ. Κεφντιτορένη - *Spectracef*, Κεφιξίμη - *Ceftoral*) και οι νεότερες Κινολόνες από του στόματος, μπορούν να χορηγηθούν, επίσης χωρίς αντιβιογράμμα, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο και εφόσον εκεί χορηγείτο παρεντερικά Κεφαλοσπορίνη 3^{ης} ή 4^{ης} γενεάς ή Αζτρεονάμη ή παρεντερική Κινολόνη και αν μετά τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς είναι δυνατή η ταχύτερη έξοδός του από το νοσοκομείο και η συνέχιση της νοσηλείας στο σπίτι με χορήγηση μιας Κεφαλοσπορίνης 3^{ης} γενεάς από του στόματος ή αντίστοιχης Κινολόνης από του στόματος (*Σιπροφλοξασίνη, Λεβοφλοξασίνη, Μοξιφλοξασίνη, Προυλιφλοξασίνη*).

Για τις από του στόματος Κεφαλοσπορίνες 3^{ης} γενεάς, ισχύει επίσης ότι μπορούν να χορηγηθούν χωρίς αντιβιογράμμα σε ασθενείς με εμπύρετο και υποκείμενες κακοήθειες, καθώς και σε ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και HIV λοίμωξη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Πρέπει να αποφεύγουμε να συστήνουμε ή να συνταγογραφούμε κινολόνες και γενικώς προχωρημένα αντιβιοτικά, χωρίς κλινικές ενδείξεις και ιδίως όταν υπάρχουν άλλα εξίσου αποτελεσματικά φάρμακα. Οι κινολόνες είναι από τα τελευταία όπλα που διαθέτει η ιατρική, στις οποίες τα επίπεδα μικροβιακής αντοχής δεν είναι μεγάλα (*δυστυχώς, ήδη εμφανίζονται πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων με αυξημένη αντοχή σε ισχυρά αντιβιοτικά όπως οι κινολόνες*). Εάν λοιπόν καταχραστούμε αυτά τα φάρμακα κι αναπτυχθούν σύντομα και σε μεγάλη κλίμακα ευρέως ανθεκτικά στελέχη, η κατάσταση θα γίνει σαφώς πιο δύσκολη από ό,τι είναι σήμερα.

Εάν ο ασθενής έχει ήδη προμηθευτεί από το φαρμακείο ένα σκεύασμα Κινολόνης που του σύστησε ο Φαρμακοποιός ή ο Μικροβιολόγος, καλό είναι να του εξηγήσουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αλόγιστη χρήση τέτοιων φαρμάκων. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε – για να μη γίνουμε δυσάρεστοι – και αρχίζουμε να αναγράφουμε ψεύτικες διαγνώσεις, προκειμένου να συνταγογραφήσουμε σκεύασμα Κινολόνης. Μπορεί να το πράξουμε, σποραδικά ίσως, μόνο για λόγους πολιτικής (π.χ. *τις πρώτες ημέρες της θητείας στο Περιφερειακό Ιατρείο ή στο ΚΥ*).

Στην Ελλάδα, φευ, που καταφέρνουμε πάντοτε να είμαστε από τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω, να ευαισθητοποιηθούμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς μας και τον περίγυρο μας πάνω σε αυτό το θέμα, όπως και στην μείωση γενικότερα της λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ή άνευ ενδείξεων.

Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές στους ασθενείς μας ότι χωρίς αντιβιογράμμα δεν συνταγογραφούνται αυτά τα φάρμακα, εάν δεν τα δικαιολογεί η πάθηση του ασθενούς.